

糖尿病足病临床路径

(2016年版)

一、糖尿病足病标准住院流程

(一) 适用对象。

适用对象：第一诊断为糖尿病足病(ICD. 10:E14. 601)。

(二) 诊断依据。

根据《糖尿病足国际临床指南》(国际糖尿病足工作组, 2003 年、2011 年)、《临床治疗指南. 内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著, 人民卫生出版社, 2009 年)、《临床技术操作规范—内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著, 人民军医出版社, 2009 年)、《糖尿病足感染诊断和治疗的临床实用指南》(美国感染疾病协会, 2012 年)、《糖尿病诊疗标准(2012)版》(美国糖尿病协会, 2015)。

(1)有糖尿病病史;

(2)具备糖尿病足病的特点: 既往有溃疡、截肢、持续治疗等病史(包括血管重建); 下肢远端神经异常; 不同程度的周围血管病变; 足部感染、溃疡和(或)深层组织坏死。破感染的诊断应根据炎症的临床表现,而不仅仅依靠培养的结果。应在去除胼胝和坏死组织后, 根据创面的范围和深度以及全身情况评价感染的严重程度。

(三) 进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合糖尿病足病疾病编码(ICD. 10: E14. 601)。

2. 当患者同时具有其他疾病诊断。但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

(四) 标准住院日。

≤28 天

(五) 住院期间的检查项目。

1. 必需的检查项目：

血常规、尿常规、大便常规；全天毛细血管血糖谱(三餐前、三餐后、睡前、必要时 0:00、3:00)：血糖、肝肾功能、电解质、血脂谱、血浆蛋白水平、C 反应蛋白、红细胞沉降率；HbA1c；足溃疡创面细菌培养+药物敏感试验；双足 x 线片：胸片、心电图、腹部超声；并发症相关检查：尿白蛋白 / 肌酐、24 h 尿蛋白定量、眼底检查、超声心动图、下肢动脉血管彩超、颈动脉血管彩超等。

2. 根据患者病情进行的检查项目：

双足多普勒血流图测定踝肱比值；肌电图测定神经传导速度、外周神经感觉测定；双下肢 TcPO₂ 测定；血培养+药物敏感试验；双足核磁共振(MRI)：双下肢动脉多排螺旋 CT 血管成像(CTA)或核磁共振血管成像(MRA)。

(六) 治疗方案的选择。

根据《糖尿病足国际临床指南》（国际糖尿病足工作组，2003 年、2011 年）、《临床治疗指南．内分泌及代谢性疾病分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社，2009 年）、《临床技术规范一内分泌及代谢性疾病分册》（中华医学会编著，人民军医出版社，2009 年）、《糖尿病足感染诊断和治疗的临床实用指南》（美国感染疾病协会，2012 年）、《糖尿病诊疗标准(2012)版》（美国糖尿病协会．201）。

(1)降糖药物治疗方案选择及剂量调整：根据病情选择胰岛素和其他口服或注射降糖药物。

(2) 抗生素使用方案的选择：根据病情选择适当的抗生素。

(3) 扩张血管抗凝药物使用方案的选择：针对动脉血管闭塞应用扩张血管改善血液循环和抗凝药物。

(4) 神经病变治疗药物。

（七）预防性抗菌药物选择与使用时机。

根据病情选择适当的抗生素。

（八）常见伴随疾病的药物治疗（如高血压，冠心病，陈旧脑梗死等）

根据伴随疾病情况选择适当的药物及治疗方案。

（十）出院标准。

1. 临床病情已稳定；
2. 局部清创已经完成；

3. 血糖控制达标；
4. 后续治疗计划明确。

(十一) 变异及原因分析。

(1) 出现急性并发症(低血糖昏迷、高渗性高血糖昏迷、酮症酸中毒、乳酸酸中毒等)，退出本路径。

(2) 出现急性合并症(合并急性心肌梗塞、急性脑梗塞、下肢动脉栓塞、肺栓塞、重症肺炎等)，退出本路径。

(3) 出现严重的糖尿病慢性并发症(糖尿病肾病、眼部、心血管、神经系统并发症、皮肤病变)或合并其他感染，导致住院时间延长、住院费用增加。

二、糖尿病足病临床路径表单

适用对象：第一诊断为糖尿病足病 (ICD-10: E14.601)

患者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 门诊号：_____ 住院号：_____

住院日期：____年__月__日 出院日期：____年__月__日 标准住院日：≤28 天

时间	住院第 1 天	住院第 2-26 天	住院第 27-28 天 (出院日)
主要诊疗工作	☐ 询问病史及体格检查 ☐ 完成病历书写 ☐ 完善检查 ☐ 上级医师查房与病情评估 ☐ 初步确定治疗方案	☐ 上级医师查房 ☐ 明确诊断 ☐ 完成必要的相关科室会诊 ☐ 复查相关异常检查 ☐ 注意病情变化 ☐ 调整治疗	☐ 上级医师查房，明确是否出院 ☐ 完成出院记录、病案首页、出院证明书等 ☐ 向患者交代出院后的注意事项
重点医嘱	长期医嘱： ☐ 内科护理常规 ☐ 二级护理 ☐ 糖尿病饮食 ☐ 毛细血管 5-7 点血糖谱、必要时监测 0 点和凌晨 3 点血糖 ☐ 胰岛素治疗 ☐ 口服降血糖药物治疗(必要时) ☐ 周围神经病变用药 ☐ 扩张血管抗凝药物 ☐ 抗生素应用 ☐ 对症用药 临时医嘱： ☐ 血常规、尿常规、大便常规 ☐ 肝肾功能、血浆蛋白、电解质、血糖、血脂、血沉、C 反应蛋白 ☐ HbA1c ☐ 尿微量蛋白肌酐比值、24h 尿蛋白 ☐ 腹部超声 ☐ 周围血管(动脉超声) ☐ 胸片、心电图、心动超声 ☐ 眼底检查 ☐ 可选项目：双足多普勒血流图测定踝肱比值、肌电图测	长期医嘱： ☐ 内科护理常规 ☐ 二级护理 ☐ 糖尿病饮食 ☐ 调整胰岛素治疗 ☐ 口服降血糖药物剂量和/或种类的调整 ☐ 周围神经病变药物剂量和/或种类的调整 ☐ 扩张血管抗凝药物调整 ☐ 抗生素应用调整 ☐ 对症用药 临时医嘱： ☐ 根据病情补充相关检测 ☐ 根据病情补充相关治疗	出院医嘱： ☐ 出院带药 ☐ 门诊随访

	定神经传导速度、外周神经感觉测定、双下肢 TcPO ₂ 、血培养+药物敏感试验、双足核磁共振 (MRI)、双下肢动脉多排螺旋 CT 血管成像 (CTA) 或核磁共振血管成像 (MRA)		
主要护理工作	☐ 介绍病房环境、设施和设备 ☐ 入院护理评估	☐ 病情观察 ☐ 观察治疗反应	☐ 指导患者办理出院手续
病情变异记录	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.
护士签名			
医师签名			